

[일반원칙]고혈압약제

분류 고시 | 관련근거 고시 제2023-23호(약제) | 게시일 2023-02-01 | 조회수 7045

 고시 제2023-23호 [일반원칙] 고혈압약제.hwp

첨부파일 다운로드↓

- 

자료가 다운로드 않을 경우 담당부서로 연락주시기 바랍니다.
- 

첨부파일명이 한글로 되어있는 경우 다운로드시 확인해 주세요.

■ 고시 개정 전체내용

동반질환 및 합병증이 없는 고혈압 환자에게 투여하는 혈압강화제는 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함.

-아 래-

가. 약제 치료 시점

- 1) 수축기혈압 140mmHg 이상 또는 이완기혈압90mmHg 이상에서 약제 투여를 시작할 수 있음.
- 2) 심혈관계질환 위험인자를 동반하지 않는 환자에서는 우선적으로 생활습관 개선을 권고함.

나. 약제 투여원칙

- 1) 혈압강화제는 1종부터 투여하며, 수축기혈압이 160mmHg 이상 또는 이완기혈압이 100mmHg 이상일 경우 처음부터 2제 요법 인정 가능함.
- 2) 혈압강화제를 투여해도 수축기혈압이 140mmHg 이상 또는 이완기혈압이 90mmHg 이상이면 다른 기전의 혈압강화제를 1종씩 추가할 수 있음. 다만, 4 성분군이상 투여할 경우 투여소 건 기재 시 사례별로 인정함.
- 3) 2제 요법 시 다음의 병용 조합은 권장하지 아니하며, 타당한 사유 기재 시 사례별로 인정함.

-다 음-

가) Diuretic + α Blocker

나) β Blocker + ACE inhibitor

다) β Blocker + Angiotensin II receptor antagonist

라) ACE inhibitor + Angiotensin II receptor antagonist

4) 동일 성분군의 혈압강화제는 1종 투여하며, 복합제는 복합된 성분수의 약제를 투여한 것으로 인정함.

※ 대상환자 : 아래의 동반질환 또는 합병증이 없는 고혈압 환자

· 심혈관계질환: 협심증, 심근경색, 좌심실비대, 심부전, 허혈성 심질환

· 뇌혈관질환

· 만성신질환(단백뇨 포함)

· 당뇨병

· 말초혈관질환

※ 대상약제: 아래의 성분을 포함하는 단일제 및 복합제

(관련표는 아래 첨부파일 고시 제2023-23호 참고하시기 바랍니다)

■ 고시 개정 고시번호(시행일자)

고시 제2023-23호(2023.2.1.)

■ 고시 개정 사유

Azelnidipine 성분의 고혈압 치료제가 신규등재 예정('23.2월)임에 따라 급여기준의 일반원칙에 성분명 추가

■ 관련문헌 등

· CURRENT Diagnosis & Treatment: Cardiology, 5e (2022)

· Hurst's The Heart, 14e (2017)

· The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension (JSH 2019)

· WHO Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults (2021)

· 2018년 고혈압 진료지침, 대한고혈압학회

· 대한고혈압학회 (대고학 제2021-025호, 2022.02.18.)

· Zhao et al. Azelnidipine and Amlodipine: A Comparison of Their Effects and Safety in a Randomized Double-Blinded Clinical Trial in Chinese Essential Hypertensive Patient s. Clinical and Experimental Hypertension, 32(6): 372 ? 376, (2010)

· Masanori Abe et al. Additive antioxidative effects of azelnidipine on angiotensin receptor blocker olmesartan treatment for type 2 diabetic patients with albuminuria. Hypertension Research (2011) 34, 935 ? 941

· Daikuhara et al. The combination of OLmesartan and a Calcium channel blocker (azelnidipine) or candesartan and a calcium channel blocker (amlodipine) in type 2 diabetic hypertensive patients: The OLCA study. Diabetes & Vascular Disease Research 9(4) 280 ? 286

· Takeshi Takami et al. Azelnidipine plus olmesartan versus amlodipine plus olmesartan on arterial stiffness and cardiac function in hypertensive patients: a randomized trial. Drug Design, Development and Therapy 2013;7 175 ? 183

· Susumu OGAWA et al. Combination Therapy with Renin-Angiotensin System Inhibitors and the Calcium Channel Blocker Azelnidipine Decreases Plasma Inflammatory Markers and Urinary Oxidative Stress Markers in Patients with Diabetic Nephropathy. Hypertens Res 2008; 31:1147 ? 1155

■ 변경 전 고시번호(시행일자)

고시 제2017-215호(2017.12.1.)